



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РАДІОХІРУРГІЇ



ФЕОФАНІЯ



ВІДДІЛЕННЯ ПЕТ-КТ ДІАГНОСТИКИ

Пацієнт: Жерлїцина Анастасія Станіславівна, 1976 р.н.

ПЕТ/КТ всього тіла з контрастним підсиленням

2025.05.13 / #53478/25

Внутрішньовенно введено F18ДГ - 277.29999 МБк, кат. - АД, ефективна доза ПЕТ - 5.3000002 мЗв, КТ - 21.200001 мЗв

Протокол дослідження:

Попередні дані: GIST тіла матки з mts в печінку, по черевині 08/2022; ПХТ 4 цикли гемцитабін + доцетаксел + авастін до 10/202; прогресія; ПХТ пазопаніб до 12.01.2023; прогресія з mts в печінку; ПХТ трабектидін до 03/2023; прогресія; ПХТ іматиніб 4 місяці до 08/2023; частковий регрес на ПЕТ/КТ; ПХТ іматиніб до 03/2025.

Контроль після лікування

Не надано Dicom дані попередніх ПЕТ для порівняння.

Референтні значення: медіастинальний пул - SUVmax 1,57; пул печінки - SUVmax 2,37.

Пневматизація верхньощелепних синусів не порушена.

Артефакти від дентальних конструкцій в області лицьового черепа.

Відмічається відносно симетричний метаболізм радіофармпрепарату в області піднебінних мигдаликів.

М'язи дна ротової порожнини симетричні.

Підщелепні лімфовузли одиничні до 0,5см, неактивні.

Глотка та гортань мають чіткі контури та нормальну товщину стінок.

Ознак шийної лімфаденопатії не виявлено; поодинокі дрібні лімфовузли в каротидних просторах, по бічному відділам ший, розміром до 0,7см, метаболічно неактивні.

Щитоподібна залоза не збільшена, структура звичайна.

Звичайний розподіл жирової та залозистої тканини в обох молочних залозах, без ПЕТ/КТ чутливої патології.

В аксілярних ділянках та під грудними м'язами поодинокі лімфовузли до 1,2см з ознаками жирової трансформації, без ознак метаболічної активності.

Порт в правій підключичній вені.

Ознак медіастинальної лімфаденопатії не виявлено, тканина переднього середостіння ущільнена. Трахея та головні бронхи звичайні. Корені структурні.

Легені - по всім сегментам звичайної пневматизації, одиничні дрібні були справа в SI субплеврально до 0,8см; інфільтративних та вогнищевих змін не виявлено. Рідина в плевральних порожнинах відсутня.

Куполи діафрагми звичайно розташовані.

Кістозні формації в печінці - найбільша в SVIII / SIV до 6,2x4,0см, та SV / SIV до 13,5x10см, аметаболічні, по периферії з одиничними патернами заповнення; асоційовані з перенесеним лікуванням відомого GIST.

Під кардіальним відділом шлунку подібна кістозна формація до 3,3x2,8см; без достовірного метаболізму.

Селезінка розташована звичайно, не збільшена, без вогнищевих змін.

Підшлункова залоза виглядає звичайно, контур чіткий.

Надирники не збільшені, форма збережена.

Нирки розташовані типово, їх паренхіма нормальної товщини. Чашково-мисковий комплекс, сечоводи звичайної конфігурації.

Внутрішньочеревної та заочеревинної лімфаденопатії не виявлено.

Сечовий міхур адекватно наповнений.

Тіло та шийка матки на актуальному обстеженні виглядають незміненими, без видимої ПЕТ чутливої патології. Над тілом матки по черевині практично в місці звичайного розташування тканини правого яєчника аметаболічна кістозна формація до 4,4x4,0см.

Тазової лімфаденопатії не виявлено.

В пахових ділянках лімфовузли до 1,0см, з ознаками жирової трансформації, метаболічно неактивні.

Кістково-деструктивні зміни не визначаються.

Висновок:

GIST з ураження матки, печінки, черевини. Над тілом матки по черевині аметаболічний кістозний вузол, подібний вузол під кардіальним відділом шлунку також неактивний, кістозні формації в печінці активності також не виявляють - зміни відповідають стану після ПХТ лікування, наразі активної тканини чи "свіжих" патернів не виявлено. PET negative.

Керівник ВЦРХ, лікар-рентгенолог, лікар-радіолог

Лікар-рентгенолог, лікар-радіолог

Кметюк Я.В.

Ашихмін А.В.